

보건복지부 고시 제2026-42호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-24호(2026. 1. 29.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 2월 25일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[219] Lanadelumab 주사제(품명: 탁자이로프리필드시린지주)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준, [일반원칙] 골다공증치료제, [119] Nusinersen sodium 주사제(품명: 스피라자주), [119] Risdiplam 경구제(품명: 에브리스디건조시럽), [132] olopatadine+mometasone furoate 외용제(품명: 리알트리스 나잘스프레이액), [243] Teriparatide 주사제(품명: 포스테오주 등), [243] Teriparatide acetate 주사제(품명: 테리본피하주사), [399] Denosumab 주사제(품명: 프롤리아 프리필드시린지 등), [399] Romosozumab 주사제(품명: 이베니티주프리필드시린지), [399] Zoledronic acid 5mg/100ml 주사제(품명: 대웅졸레드론산주사액 5밀리그램/100밀리리터 등), [439] Anakinra(품명 : 키너렛주)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 3월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[219] 기타의 순환계용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[219] Lanadelumab 주사제 (품명 : 탁자이로프리필드 시린지주)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 12세 이상 청소년 및 성인에서 혈청검사 등을 통해 C1-에스테라제 억제제 결핍 또는 기능장애(총량 또는 활성도)로 확진된 유전성 혈관부종(1형 또는 2형) 환자로서 다음 조건을 만족하는 경우 - 다 음 - 1) Danazol 경구제를 6개월 이상 투여하였음에도 최근 6개월동안 월평균 3회 이상 응급 치료(icatibant 주사제 투여)를 요하는 발작이 발생한 경우 2) Danazol 경구제에 금기 또는 부작용 등으로 투여할 수 없는 경우에는 동 약제 투여 이전 6개월 동안 월평균 3회 이상 응급 치료(icatibant 주사제 투여)를 요하는 발작이 발생한 경우 나. 평가방법 1) 동 약제를 6개월간 사용 후 평가하여 최초 투여시점보다 응급 치료	○ Lanadelumab 주사제 (품명 : 탁자이로 프리필드시린지주)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		(icatibant 주사제 투여)를 요하는 월평균 발작의 횟수가 50% 이상 감소된 경우 6개월의 추가 투여를 인정함. 2) 이후에도 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 2. 투여 및 약제관리 1) 원내투여를 원칙으로 하되, 최초 투약일로부터 6개월 이후 의사의 판단 하에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 투여방법에 대해 적절하게 교육 후 자가 투여를 인정하며, 자가 주사로 2개월분까지 처방 인정함. 2) 약제 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 3. 동 약제는 유전성 혈관부종이 있는 환자 치료에 경험이 있는 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(진료기록부, 검사결과지 등)를 반드시 제출하여야 함.	
--	--	---	--

※ 관련근거

- 1) Goldman-Cecil Medicine, 27e(2024)
- 2) Middleton's allergy; Principles and Practice, 9e(2020)
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2022)
- 4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e(2023)
- 5) The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema, 2021
- 6) US HAEA Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the Management of Hereditary Angioedema
- 7) The International/Canadian Hereditary Angioedema Guideline 2019
- 8) Banerji A et al. Effect of Lanadelumab Compared With Placebo on Prevention of Hereditary Angioedema Attacks. JAMA.2018;320(20):2108-2121

- 9) Banerji A et al. Long-term prevention of hereditary angioedema attacks with lanadelumab: The HELP OLE Study. *Allergy*. 2022;77:979–990
- 10) Hide et al. Efficacy and safety of lanadelumab in Japanese patients with hereditary angioedema: A phase 3 multicenter, open-label study. *The Journal of Dermatology*. 2023; 60:1331–1391.
- 11) Magerl et al. Real-World Effectiveness of Lanadelumab in Hereditary Angioedema: Multicountry INTEGRATED Observational Study. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2025;13:378–87).
- 12) 대한천식알레르기 학회(대알학 제2025-028호, 2025.3.25.).
- 13) 대한의학유전학회(대의유 2025-25, 2025.3.28.)
- 14) NICE(2019.10.)
- 15) SMC(2019.11.)
- 16) CADTH(2019.11.)
- 17) PBAC(2021.07.)
- 18) PBAC(2024.11.)
- 19) AETNA(2025.3.)

[별지 2]

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준							
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)					사유	
	현 행		개 정(안)				
[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준	고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. - 아 래 -		고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. - 아 래 -			○ 에브리스디건조시럽 등 급여기준 고시개 정에 따른 변경	
	약제명	관리 기간	비고	약제명	관리 기간		비고
	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년		비호지킨림프종에 투여한 경우
	줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년	-	줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년		-
	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년		첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우
	에브리스디건조 시럽(Risdiplam)	1년		에브리스디건조 시럽 등 (Risdiplam)	1년		
	렉스터나주	4년	-	렉스터나주	4년		-

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)					사유
	현 행			개 정(안)		
	(Voretigene neparvovec)			(Voretigene neparvovec)		
	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우
		2년	재발성·불응성에 투여한 경우		2년	재발성·불응성에 투여한 경우
	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-
	리브말리엑 (Maralixibat)	<u>5년</u>	=	리브말리엑 (Maralixibat)	<u>5년</u>	=

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 골다공증치료제	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, 글루코코르티코이드 유

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	가. 칼슘 및 Estrogen제제 등의 약제 골밀도검사 에서 T-score가 -1 이하인 경우($T\text{-score} \leq -1.0$) 나. Elcatonin제제, Raloxifene제제, Bazedoxifene 제제, 활성형 Vit D3제제 및 Bisphosphonate 제제 등의 약제(검사지 등 첨부) 1) 투여대상 가) 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle <추 가> 제외)] : 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 ($T\text{-score} \leq -2.5$) 나) 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT) : 80mg/cm³ 이하인 경우 다) 상기 가), 나)항 이외: 골밀도 측정시 T-score가 -3.0 이하인 경우($T\text{-score} \leq -3.0$) 라) 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이 확 인된 경우	가. 칼슘 및 Estrogen제제 등의 약제 골밀도검사 에서 T-score가 -1 이하인 경우($T\text{-score} \leq -1.0$) 나. Elcatonin제제, Raloxifene제제, Bazedoxifene 제제, 활성형 Vit D3제제 및 Bisphosphonate 제제 등의 약제(검사지 등 첨부) 1) 투여대상 가) 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle, Trochanter 제외)] : 이중 에너 지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 ($T\text{-score} \leq -2.5$) 나) 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT) : 80mg/cm³ 이하인 경우 다) 상기 가), 나)항 이외: 골밀도 측정시 T-score가 -3.0 이하인 경우($T\text{-score} \leq -3.0$) 라) 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이 확 인된 경우	발 골다공증으로 deno sumab에서 Alendronat e, Risedronate 경구 제로 전환투여 12개월 까지 급여 확대함.

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	* 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 2) 투여기간 가) 투여대상 다)에 해당하는 경우에는 6개월 이내 나) 투여대상 가), 나)에 해당하는 경우에는 1년 이내, 라)에 해당하는 경우에는 3년 이내로 하며, 추적검사에서 T-score가 -2.5 이하 (QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. 다) 다만, Raloxifene 제제, Bazedoxifene 제제, Bisphosphonate 제제 투여 환자로서 1) 투여대상 가)에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 1) 투여대상 가)에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하 (-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하 (-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년의 추가투여를 급여 인정함.*	* 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 2) 투여기간 가) 투여대상 다)에 해당하는 경우에는 6개월 이내 나) 투여대상 가), 나)에 해당하는 경우에는 1년 이내, 라)에 해당하는 경우에는 3년 이내로 하며, 추적검사에서 T-score가 -2.5 이하 (QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. 다) 다만, Raloxifene 제제, Bazedoxifene 제제, Bisphosphonate 제제 투여 환자로서 1) 투여대상 가)에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 1) 투여대상 가)에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하 (-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하 (-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년의 추가투여를 급여 인정함.*	

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속 투여는 2년(1년 + 1년)까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제, Bisphosphonate 개별 성분, Denosumab 주사제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능함. 다. 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음 2. 글루코코르티코이드(Glucocorticoid) 투여 환자의 경우 아래와 같은 기준으로 요양 급여를 인정함. - 아 래 - 가. 대상 약제 alendronate, risedronate 단일 제제 및 해당 성분과 cholecalciferol 복합제 나. 투여대상 6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 prednisolone을 총 450mg 이상(또는 그에 상응하는 글루코코르티코이드 약제 용량)을 투여받은	※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속 투여는 2년(1년 + 1년)까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제, Bisphosphonate 개별 성분, Denosumab 주사제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능함. 다. 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음 2. 글루코코르티코이드(Glucocorticoid) 투여 환자의 경우 아래와 같은 기준으로 요양 급여를 인정함. - 아 래 - 가. 대상 약제 alendronate, risedronate 단일 제제 및 해당 성분과 cholecalciferol 복합제 나. 투여대상 6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 prednisolone을 총 450mg 이상(또는 그에 상응하는 글루코코르티코이드 약제 용량)을 투여받은	

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	환자로서 1) 폐경 후 여성 및 만 50세 이상 남성 : T-score[※] < -1.5 2) 폐경 전 여성 및 만 50세 미만 남성 : Z-score[※] < -3.0 ※ 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle <u><추 가></u> 제외)]을 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 측정해야 한다. 다. 투여기간 1년 이내로 하며, 추적검사에서 나. 의 기준이 유지되고 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. <u><추 가></u>	환자로서 1) 폐경 후 여성 및 만 50세 이상 남성 : T-score[※] < -1.5 2) 폐경 전 여성 및 만 50세 미만 남성 : Z-score[※] < -3.0 ※ 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle, <u>Trochanter</u> 제외)]을 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 측정해야 한다. 다. 투여기간 1년 이내로 하며, 추적검사에서 나. 의 기준이 유지되고 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. 3. 글루코코르티코이드 관련하여 Denosumab 투여	

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	3. 골다공증 치료제에는 호르몬요법(Estrogen, Estrogenderivatives 등)과 비호르몬요법(Bisphosphonate, Elcatonin, 활성형 Vit.D3, Raloxifene 및 Bazedoxifene제제 등)이 있으며, 호르몬요법과 비호르몬요법을 병용투여하거나 비호르몬요법 간 병용투여는 인정하지 아니함. 다만 아래의 경우는 인정 가능함. - 아 래 - 가. 칼슘제제와 호르몬대체요법의 병용 나. 칼슘제제와 그 외 비호르몬요법의 병용 다. Bisphosphonate와 Vit.D 복합경구제(성분: Alendronate + Cholecalciferol 등)를 투여한 경우 라. Bisphosphonate 단일제와 활성형 Vit. D3 단	<u>후 Alendronate, Risedronate 경구제로 전환 투여는 12개월까지 인정하되, Denosumab 투여 종료 후 마지막 투여일로부터 7개월 이내에 투여를 시작하여야 함.</u> 4. 골다공증 치료제에는 호르몬요법(Estrogen, Estrogenderivatives 등)과 비호르몬요법(Bisphosphonate, Elcatonin, 활성형 Vit.D3, Raloxifene 및 Bazedoxifene제제 등)이 있으며, 호르몬요법과 비호르몬요법을 병용투여하거나 비호르몬요법 간 병용투여는 인정하지 아니함. 다만 아래의 경우는 인정 가능함. - 아 래 - 가. 칼슘제제와 호르몬대체요법의 병용 나. 칼슘제제와 그 외 비호르몬요법의 병용 다. Bisphosphonate와 Vit.D 복합경구제(성분: Alendronate + Cholecalciferol 등)를 투여한 경우 라. Bisphosphonate 단일제와 활성형 Vit. D3 단	

[일반원칙] 골다공증치료제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	일제 병용 마. SERM과 Vit.D 복합경구제(성분: Bazedoxifene + Cholecalciferol, Raloxifene + Cholecalciferol)를 투여한 경우 ※ SERM : Seletive Estrogen Receptor Modulator(선택적 에스트로겐 수용체 조절제) 4. 특정소견 없이 단순히 골다공증 예방목적으로 투여하는 경우에는 비급여 함.	일제 병용 마. SERM과 Vit.D 복합경구제(성분: Bazedoxifene + Cholecalciferol, Raloxifene + Cholecalciferol)를 투여한 경우 ※ SERM : Seletive Estrogen Receptor Modulator(선택적 에스트로겐 수용체 조절제) 5. 특정소견 없이 단순히 골다공증 예방목적으로 투여하는 경우에는 비급여 함.	

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e. 2025.
- Current Diagnosis & Treatment: Rheumatology, 4e. 2021.
- Korean Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-induced Osteoporosis. 2018.
- 2022 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis.
- NOGG. 2024.
- The 2023 Guidelines for the management and treatment of glucocorticoid induced osteoporosis.
- Saag et al. Denosumab versus risedronate in glucocorticoid-induced osteoporosis: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, double-dummy, non-inferiority study. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6: 445-54.
- Saag et al. Denosumab Versus Risedronate in Glucocorticoid-Induced Osteoporosis: Final Results of a Twenty-Four-Month Randomized, Double-Blind, Double-Dummy Trial. Arthritis & Rheumatology. Vol. 71, No. 7, July 2019, pp 1174-1184.
- Yuan et al., Clinical efficacy of denosumab, teriparatide, and oral bisphosphonates in the prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2023) 18:447.

[일반원칙] 골다공증치료제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· Dong et al., Denosumab, teriparatide and bisphosphonates for glucocorticoid-induced osteoporosis: a Bayesian network meta-analysis. Front. Pharmacol, 2024. 15:1336075.			

[119] 기타의 중추신경용약			
구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[119] Nusinersen sodium 주사제 (품명: 스피나라자주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. 평가방법 1) (생 략) 2) 운동기능은 환자의 연령, 상태 등을 고려하여 다음의 운동기능 평가도구를 사용하여 평가하고, 운동기능 평가도구의 전환이 필요한	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 평가방법 1) (현행과 같음) 2) 운동기능은 환자의 연령, 상태 등을 고려하여 다음의 운동기능 평가도구를 사용하여 평가하고, 운동기능 평가도구의 전환이 필요한	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여, 운동상태에 따른 운동기능 평가도구를 정비하고, 교체투여에 대한 기준 확대함

경우 전환시점 이후로는 두 가지 운동기능
평가결과를 3회 동안 중복하여 제출토록 함.

- 다 음 -

투여 시점 연령	운동기능평가도구 ^{주2)}
생후 24개월 이하	① CHOP-INTEND ② HINE-2
생후 24개월 초과	① HFMSE, ② RULM, HOP-INTEND, CHOP-ATEND

주2) ①은 주평가도구(필수) ②는 보조평가도구
(필요시)로 함. 생후 24개월 초과인 경우
HFMSE를 주평가도구 원칙으로 하되, 보조
평가도구로서 RULM을 사용할 수 있으며,
non-sitter 환자인 경우 CHOP-INTEND
(만5세 미만까지), CHOP-ATEND를 사용
할 수 있음.

다. (생 략)

라. 교체투여 등

다른 척수성 근위축증 치료제를 투여한 환자의
경우 동 약제로 교체투여 또는 동 약제와 병용
투여는 급여 인정하지 아니함.

경우 전환시점 이후로는 두 가지 운동기능
평가결과를 3회 동안 중복하여 제출토록 함.

- 다 음 -

투여 시점 연령	운동 상태	주평가도구	보조평가도구
생후 24개월 이하	Sitter	CHOP-INTEND, HFMSE	HINE-2
	Non-s itter	CHOP-INTEND, CHOP-ATEND	
생후 24개월 초과	Sitter	HFMSE	RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND
	Non-s itter	HFMSE, CHOP-INTEND CHOP-ATEND	RULM

주2) 주평가도구 사용을(1종 필수) 원칙으로
하며, 보조평가도구는 필요시 사용가능함.

다. (현행과 같음)

라. 교체투여 등

척수성 근위축증 치료제 간 교체투여 또는 병용투
여는 급여 인정하지 아니하나, 아래 중 하나에 해
당하는 경우 위원회 판단하에 요양급여 인정함

- 아 래 -

	마. (생 략) 2~3. (생 략)	1) <u>risdiplam 경구제 투여 중 개선이 확인되고 중단기준에 해당하지 않으며, 임상적 사유(심각한 불내성 등)가 있는 경우 1회에 한하여 동 약제로 교체투여 인정함</u> 2) <u>급여기준에 따라 동 약제에서 risdiplam 경구제로 교체 투여 후 중단기준에 해당하지 않으며, 임상적 사유(심각한 불내성 등)가 있는 경우 1회에 한하여 동 약제로의 교체투여 인정함</u> 마. (현행과 같음) 2~3. (현행과 같음)	
--	-----------------------------------	---	--

※ 관련근거

- Neurologic assessment & neurodiagnostics, 27th 2025
- Clinical Neurology & Neuroanatomy 2e 2022
- Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 : Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Nueromuscular (2018)
- Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2 : Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. (2018)
- Finkel, R. S., et al. Nusinersen versus sham control in infantile-onset spinal muscular atrophy. New England Journal of Medicine, 2018;377(18), 1723-1732.
- Finkel, R. S., et al. Treatment of infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, dose-escalation study. The Lancet, 2016;388(10063), 3017-3026.
- O'Hagen, J. M., et al. An expanded version of the Hammersmith Functional Motor Scale for SMA II and III patients. Neuromuscular Disorders, 2007; 17(9-10), 693-697.
- van der Woude, D. R., et al. Exploring functional strength changes during nusinersen treatment in symptomatic children with SMA types 2 and 3. Neuromuscular Disorders, 2023; 41, 1-7.
- Yoon, J. A., et al. Improvement in functional motor scores in patients with non-ambulatory spinal muscle atrophy during Nusinersen treatment in South Korea: a single center study. BMC neurology, 2024;24(1), 210.
- Pierzchlewicz, K., et al. Spinal muscular atrophy: the use of functional motor scales in the era of disease-modifying treatment. Child neurology open, 2021;8, 2329048X211008725.
- Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd, 2025 > Chapter 652
- Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care
- Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics
- Spinal Muscular Atrophy Update in Best Practices Recommendations for Treatment Considerations
- MERCURI, Eugenio, et al. Patterns of disease progression in type 2 and 3 SMA: implications for clinical trials. Neuromuscular Disorders, 2016, 26.2: 126-131.
- WIJNGAARDE, Camiel A., et al. Natural course of scoliosis and lifetime risk of scoliosis surgery in spinal muscular atrophy. Neurology, 2019, 93.2: e149-e158
- APONTE RIBERO, Valerie, et al. Systematic literature review of the natural history of spinal muscular atrophy: motor function, scoliosis, and contractures. Neurology, 2023, 101.21: e2103-e2113.
- GNAZZO, Martina, et al. Scoliosis in spinal muscular atrophy in the era of disease-modifying therapy: a scoping review. Neurological Sciences, 2025, 1-12.

- FARBER, Harold J., et al. Impact of scoliosis surgery on pulmonary function in patients with muscular dystrophies and spinal muscular atrophy. *Pediatric Pulmonology*, 2020, 55.4: 1037-1042.
- DUNAWAY YOUNG, Sally, et al. Scoliosis surgery significantly impacts motor abilities in higher-functioning individuals with spinal muscular atrophy. *Journal of neuromuscular diseases*, 2020, 7.2: 183-192.
- CHIRIBOGA, Claudia A., et al. JEWELFISH: 24-month results from an open-label study in non-treatment-naïve patients with SMA receiving treatment with risdiplam. *Journal of Neurology*, 2024, 271.8: 4871-4884.
- BEKIRCAN-KURT, Can Ebru, et al. Transitioning from Nusinersen to Risdiplam for spinal muscular atrophy in clinical practice: a single-center experience. *Muscle & Nerve*, 2025, 71.3: 414-421.
- FGRIMALDI, Lamiae, et al. REGISTRE SMA FRANCE: A nationwide observational registry of patients with spinal muscular atrophy in France. *Journal of Neuromuscular Diseases*, 2025, 22143602251353446.
- SAITO, Kayoko, et al. Safety of Risdiplam in Japanese Patients with Spinal Muscular Atrophy: A 12-Month Interim Analysis of a Postmarketing Surveillance Study. *Neurology and Therapy*, 2025, 14.5: 2083-2094.
- SIGNORIA, Ilaria, et al. Patient-specific responses to SMN2 splice-modifying treatments in spinal muscular atrophy fibroblasts. *Molecular Therapy Methods & Clinical Development*, 2024, 32.4.
- Bioequivalence and food effect assessment for a room-temperature stable risdiplam tablet formulation in healthy volunteers (Abstract Mar.14.)
- RAMOS-PLATT, Leigh; ELMAN, Lauren; SHIEH, Perry B. Experience and perspectives in the US on the evolving treatment landscape in spinal muscular atrophy. *International Journal of General Medicine*, 2022, 15: 7341.
- ZHANG, Dingding, et al. Disease characteristics and treatment status of genetically confirmed spinal muscular atrophy patients: a cross-sectional survey in China. *BMC neurology*, 2025, 25.1: 411.
- NICE/ NICE Questions and answers on the managed access agreement for risdiplam (January 2022)
- CADTH/ CADTH Drugs for Adults With Spinal Muscular Atrophy: A Focused Review and Critical Appraisal of Recent Evidence (2021 to 2025) on Nusinersen and Risdiplam (June 2025)
- PBAC
- SMC
- AETNA
- BCBS(BlueCrossBlueShield) Texas, Minnesota
- HSE
- NHI

[119] 기타의 중추신경용약			
구 분	현 행	개 정(안)	사유

	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법																								
[119] Risdiplam 경구제 (품명: 에브리스디건조시 럽 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. 평가방법 1) (생 략) 2) 운동기능은 환자의 연령, 상태 등을 고려하여 다음의 운동기능 평가도구를 사용하여 평가하고, 운동기능 평가도구의 전환이 필요한 경우 전환시점 이후로는 두 가지 운동기능 평가결과를 3회 동안 중복하여 제출토록 함. - 다 음 - <table><tr><td>투여 시점 연령</td><td>운동기능평가도구^{주2}</td></tr><tr><td>생후 24개월 이하</td><td>① CHOP-INTEND ② HINE-2</td></tr><tr><td>생후 24개월 초과</td><td>① HFMSE, ② RULM, HOP-INTEND, CHOP-ATEND</td></tr></table> 주2) ①은 주평가도구(필수) ②는 보조평가도구(필요시)로 함. 생후 24개월 초과인 경우	투여 시점 연령	운동기능평가도구 ^{주2}	생후 24개월 이하	① CHOP-INTEND ② HINE-2	생후 24개월 초과	① HFMSE, ② RULM, HOP-INTEND, CHOP-ATEND	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 평가방법 1) (현행과 같음) 2) 운동기능은 환자의 연령, 상태 등을 고려하여 다음의 운동기능 평가도구를 사용하여 평가하고, 운동기능 평가도구의 전환이 필요한 경우 전환시점 이후로는 두 가지 운동기능 평가결과를 3회 동안 중복하여 제출토록 함. - 다 음 - <table><tr><td>투여 시점 연령</td><td>운동 상태</td><td>주평가도구</td><td>보조평가도구</td></tr><tr><td rowspan="2">생후 24개월 이하</td><td>Sitter</td><td>CHOP-INTEND, HFMSE</td><td rowspan="2">HINE-2</td></tr><tr><td>Non-sitter</td><td>CHOP-INTEND, CHOP-ATEND</td></tr><tr><td rowspan="2">생후 24개월 초과</td><td>Sitter</td><td>HFMSE</td><td>RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND</td></tr><tr><td>Non-sitter</td><td>HFMSE, CHOP-INTEND CHOP-ATEND</td><td>RULM</td></tr></table> 주2) 주평가도구 사용을(1종 필수) 원칙으로 하며, 보조평가도구는 필요시 사용가능함.	투여 시점 연령	운동 상태	주평가도구	보조평가도구	생후 24개월 이하	Sitter	CHOP-INTEND, HFMSE	HINE-2	Non-sitter	CHOP-INTEND, CHOP-ATEND	생후 24개월 초과	Sitter	HFMSE	RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND	Non-sitter	HFMSE, CHOP-INTEND CHOP-ATEND	RULM	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여, 운동상태에 따른 운동기능 평가도구를 정비하고, 교체투여에 대한 기준 확대하며, 장기처방 시 1회 처방 용량을 확대하고, ‘에브리스디정5밀리그램’의 제형이 다른 점을 고려하여 품명에 ‘등’을 추가함
투여 시점 연령	운동기능평가도구 ^{주2}																									
생후 24개월 이하	① CHOP-INTEND ② HINE-2																									
생후 24개월 초과	① HFMSE, ② RULM, HOP-INTEND, CHOP-ATEND																									
투여 시점 연령	운동 상태	주평가도구	보조평가도구																							
생후 24개월 이하	Sitter	CHOP-INTEND, HFMSE	HINE-2																							
	Non-sitter	CHOP-INTEND, CHOP-ATEND																								
생후 24개월 초과	Sitter	HFMSE	RULM, CHOP-INTEND, CHOP-ATEND																							
	Non-sitter	HFMSE, CHOP-INTEND CHOP-ATEND	RULM																							

	<u>HFMSE를 주평가도구 원칙으로 하되, 보조 평가도구로서 RULM을 사용할 수 있으며, non-sitter 환자인 경우 CHOP-INTEND (만5세 미만까지), CHOP-ATEND를 사용할 수 있음.</u> 다. (생 략) 라. 교체투여 등 <u>동 약제를 포함한 척수성 근위축증 치료제 간 교체투여 또는 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 다만, 스피라자주 투여 중 개선이 확인되고 중단기준에 해당하지 않으나, 동 약제로의 교체투여가 필요한 임상적 사유가 있는 것으로 위원회가 판단한 경우에 한해 한번의 교체투여가 가능함.</u> 마. (생 략) 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내 처방을 원칙으로 하고, <u>장기처방 시 1회 처방 용량은 퇴원 및 외래의 경우 최대 3병으로 함.</u>	다. (현행과 같음) 라. 교체투여 등 <u>척수성 근위축증 치료제 간 교체투여 또는 병용투여는 급여 인정하지 아니하나, 아래 중 하나에 해당하는 경우 위원회 판단하에 요양 급여 인정함</u> - 아 래 - 1) <u>nusinersen sodium 주사제 투여 중 개선이 확인되고 중단기준에 해당하지 않으며, 임상적 사유(해부학적 사유 등)가 있는 경우 1회에 한하여 동 약제로 교체투여 인정함</u> 2) <u>급여기준에 따라 동 약제에서 nusinersen sodium 주사제로 교체 투여 후 중단기준에 해당하지 않으며, 임상적 사유(해부학적 사유 등)가 있는 경우 1회에 한하여 동 약제로의 교체투여 인정함</u> 마. (현행과 같음) 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내 처방을 원칙으로 하고, <u>장기처방 시 에브리스디정의 1회 처방 용량은 최대 56일분까지 인정하며, 에브리스디건조시럽은 허가사</u>	
--	--	--	--

	나. (생 략) 3. (생 략) 4. <u>에브리스디건조시럽의 사전승인·성과관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하며, 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.</u>	<u>항 중 ‘사용상의 주의사항(보관 및 취급상의 주의사항)’을 참고하여 처방하도록 함.</u> 나. (현행과 같음) 3. (현행과 같음) 4. <u>에브리스디건조시럽, 에브리스디정의 사전승인·성과관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하며, 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.</u>	
※ 관련근거 • Neurologic assessment & neurodiagnostics, 27th 2025 • Clinical Neurology & Neuroanatomy 2e 2022 • Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 : Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Nueromuscular (2018) • Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2 : Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. (2018) • Finkel, R. S., et al. Nusinersen versus sham control in infantile-onset spinal muscular atrophy. New England Journal of Medicine, 2018;377(18), 1723-1732. • Finkel, R. S.,et al..Treatment of infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, dose-escalation study. The Lancet, 2016;388(10063), 3017-3026. • O’Hagen, J. M., ,et al..An expanded version of the Hammersmith Functional Motor Scale for SMA II and III patients. Neuromuscular Disorders, 2007; 17(9-10), 693-697. • van der Woude, D. R., ,et al.. Exploring functional strength changes during nusinersen treatment in symptomatic children with SMA types 2 and 3. Neuromuscular Disorders, 2023; 41, 1-7. • Yoon, J. A., et al.. Improvement in functional motor scores in patients with non-ambulatory spinal muscle atrophy during Nusinersen treatment in South Korea: a single center study. BMC neurology, 2024;24(1), 210. • Pierzchlewicz, K., et al.. Spinal muscular atrophy: the use of functional motor scales in the era of disease-modifying treatment. Child neurology open, 2021;8, 2329048X211008725. • Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd, 2025 > Chapter 652 • Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care • Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics • Spinal Muscular Atrophy Update in Best Practices Recommendations for Treatment Considerations • Bioequivalence and food effect assessment for a room-temperature stable risdiplam tablet formulation in healthy volunteers (Abstract Mar.14.) • NICE/ NICE Questions and answers on the managed access agreement for risdiplam (January 2022) • CADTH/ CADTH Drugs for Adults With Spinal Muscular Atrophy: A Focused Review and Critical Appraisal of Recent Evidence (2021 to 2025) on Nusinersen and Risdiplam (June 2025)			

- PBAC
- SMC
- AETNA
- BCBS(BlueCrossBlueShield) Texas, Minnesota
- HSE
- NHIrossBlueShield) Texas, Minnesota . HSE

[132] 이비과용제

구 분	현 행	개 정(안)	사 유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[132] olopatadine + mometasone furoate 외용제 (품명: 리알트리스 나잘스프레이액)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ <u>성인 및 12세 이상 청소년</u> 의 계절 알레르기 비염 <u><추 가></u>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ <u>6세 이상 소아 및 성인</u> 의 계절 알레르기 비염 <u>※ 단, 6세 이상 11세 이하 소아의 경우 동 약제의 허가사항 중 ‘용법·용량’을 반드시 참고하여 투여토록 함.</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여 6세 이상 11세 소아의 계절 알레르기 비염에 급여 확대

※ 관련 근거

- 대한소아알레르기호흡기학회, 소아알레르기 호흡기학 제3판, 여문각, 2018 > Chapter 5. 알레르기비염
- Current Medical Diagnosis & Treatment 2026 > 8-11: Allergic Rhinitis

- Nelson Essential of Pediatrics, 9e, 2023 > 79. Allergic Rhinitis
- Allergy Essentials, 2e, 2022 > 8. Allergy Rhinitis and Conjunctivitis
- 대한천식알레르기학회 알레르기비염 진료지침: 파트 1. 약물치료의 업데이트. 2023.
- Jan L. Brożek. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines–2016 revision, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 140, Issue 4, 2017, Pages 950–958.
- Dykewicz MS, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020 Oct;146(4):721–767.
- Wise, S. K. et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis – 2023. Int Forum Allergy Rhinol. 2023 Apr;13(4):293–859.
- Scadding, G. K. et al. Allergic Rhinitis in Childhood and the New EUFOREA Algorithm, Frontiers in Allergy, January 1, 2021; 2();706589.
- Prenner BM, et al. Efficacy and safety of GSP301 nasal spray in children aged 6 to 11 years with seasonal allergic rhinitis, Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Volume 129, Issue 5, 2022, Pages 618–626.e2.
- Hampel FC, et al. Olopatadine–mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2019 Jul 3;40(4):261–272.
- Gross Gary N, et al. Efficacy and safety of olopatadine–mometasone combination nasal spray for the treatment of seasonal allergic rhinitis, Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Volume 122, Issue 6, 2019, Pages 630–638.e3.
- Patel P, et al. Effect of olopatadine–mometasone combination nasal spray on seasonal allergic rhinitis symptoms in an environmental exposure chamber study, Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Volume 122, Issue 2, 2019, Pages 160–166.e1.
- Nenasheva N.M, et al. Efficacy and safety of the combined preparation GSP 301 NS in patients with seasonal allergic rhinitis: a Russian multicenter randomized open-label clinical trial. Practical Allergology. 2021. No.1. P.66–77.
- Segall N, et al. Long-term safety and efficacy of olopatadine–mometasone combination nasal spray in patients with perennial allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2019 Sep 1;40(5):301–310.

[243] 갑상선, 부갑상선호르몬제

구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[243] Teriparatide 주사제 (품명: 포스테오주 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 골흡수억제제(Bisphosphonate, SERM 제제. 단, SERM 제제는 ① 전신성 과민반응 ② 중증 신 부전(eGFR < 30mL/min) ③ 약제 관련 턱뼈괴사 (MRONJ) ④ 비전형 대퇴 골절 중 어느 하나에 해 당하여 Bisphosphonate를 사용할 수 없는 경우에 한함.) 중 한 가지 이상에 효과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle <추 가> 제외)]에서 이중 에너지 방사 선 흡수계측(Dual-Energy X-ray	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 골흡수억제제(Bisphosphonate, SERM 제제. 단, SERM 제제는 ① 전신성 과민반응 ② 중증 신 부전(eGFR < 30mL/min) ③ 약제 관련 턱뼈괴사 (MRONJ) ④ 비전형 대퇴 골절 중 어느 하나에 해 당하여 Bisphosphonate를 사용할 수 없는 경우에 한함.) 중 한 가지 이상에 효과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle, Trochanter 제외)]에서 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray	○ 문구 재정비

	Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한 자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간 최대 24개월. 한 환자의 일생에서 24개월 과정을 반복해서는 안됨. 다. Teriparatide acetate 주사제(품명: 테리본피하 주사)와 교체투여는 급여로 인정하지 않음. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함. * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한 자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간 최대 24개월. 한 환자의 일생에서 24개월 과정을 반복해서는 안됨. 다. Teriparatide acetate 주사제(품명: 테리본피하 주사)와 교체투여는 급여로 인정하지 않음. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함. * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	
[243] Teriparatide acetate 주사제 (품명: 테리본피하주사)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 골흡수억제제(Bisphosphonate, SERM 제제. 단, SERM 제제는 ① 전신성 과민반응 ② 중증 신부전(eGFR < 30mL/min) ③ 약제 관련 턱뼈괴사	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 골흡수억제제(Bisphosphonate, SERM 제제. 단, SERM 제제는 ① 전신성 과민반응 ② 중증 신부전(eGFR < 30mL/min) ③ 약제 관련 턱뼈괴사	○ 문구 재정비

(MRONJ) ④ 비전형 대퇴 골절 중 어느 하나에 해당하여 Bisphosphonate를 사용할 수 없는 경우에 한함.) 중 한 가지 이상에 효과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상의 폐경 후 여성 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle <추 가> 제외)]에서 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한 자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간 최대 72주. 한 환자의 일생에서 72주 과정을 반복해서는 안됨. 다. Teriparatide 주사제(품명: 포스테오주)와 교체 투여는 급여로 인정하지 아니함. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함.	(MRONJ) ④ 비전형 대퇴 골절 중 어느 하나에 해당하여 Bisphosphonate를 사용할 수 없는 경우에 한함.) 중 한 가지 이상에 효과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상의 폐경 후 여성 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle, Trochanter 제외)]에서 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한 자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간 최대 72주. 한 환자의 일생에서 72주 과정을 반복해서는 안됨. 다. Teriparatide 주사제(품명: 포스테오주)와 교체 투여는 급여로 인정하지 아니함. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함.	
--	---	--

	* 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	* 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	
[399] Romosozumab 주사제 (품명: 이베니티주프리 필드시린지)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 Bisphosphonate 제제 중 한 가지 이상에 효 과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건 을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상의 폐경 후 여성 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle <추 가> 제외)]에서 이중 에너지 방 사선 흡수 계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검 사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생 한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 기존 Bisphosphonate 제제 중 한 가지 이상에 효 과가 없거나* 사용할 수 없는 환자로 다음의 조건 을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 65세 이상의 폐경 후 여성 2) 중심골[Central bone: 요추, 대퇴(Ward's triangle, Trochanter 제외)]에서 이중 에너지 방사선 흡수 계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)으로 측정한 골밀도 검 사결과 T-score -2.5 SD 이하 3) 골다공증성 골절*이 2개 이상 발생(과거에 발생 한 골절에 대해서는 골다공증성 골절에 대한	○ 문구 재정비

	자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간: 일생에서 1개월 간격으로 총 12회까지만 인정 다. 평가방법: 동 약제 투여 종료 후 골밀도검사를 실시하여 기저치 대비 동일 또는 개선이 확인되는 경우 골흡수억제제로 전환 투여 인정 라. 골흡수억제제(Alendronate 경구제 또는 Denosumab 주사제)로 전환 투여는 동 약제 투여 종료 후 마지막 투여일로부터 1개월 이내에 투여를 시작하고, 최대 12개월까지 인정 마. 동 약제의 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항(지난 1년 이내에 심근경색이나 뇌졸중이 있었던 환자 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함. * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	자료를 첨부하여야 함.) 나. 투여기간: 일생에서 1개월 간격으로 총 12회까지만 인정 다. 평가방법: 동 약제 투여 종료 후 골밀도검사를 실시하여 기저치 대비 동일 또는 개선이 확인되는 경우 골흡수억제제로 전환 투여 인정 라. 골흡수억제제(Alendronate 경구제 또는 Denosumab 주사제)로 전환 투여는 동 약제 투여 종료 후 마지막 투여일로부터 1개월 이내에 투여를 시작하고, 최대 12개월까지 인정 마. 동 약제의 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항(지난 1년 이내에 심근경색이나 뇌졸중이 있었던 환자 등)’을 반드시 참고하여 투여하여야 함. ※ 효과가 없는 경우란 1년 이상 충분한 투여에도 불구하고 새로운 골절*이 발생한 경우를 의미함. * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절	
※ 관련근거			

< 「[심사지침] 골다공증 약제 사용에 있어 다334가 골밀도검사(DXA)의 결과(중심골)의 평가방법(‘25.6.1.시행)」에 따른 문구 재정비 >

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[399] Denosumab 주사제 (품명: 프롤리아 프리필드시린지 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u><추 가></u> <u>가.</u> 투여대상 1) 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle <u><추 가></u> 제외)]: 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 ($T\text{-score} \leq -2.5$). 2) 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT): 80mg/cm³ 이하인 경우 3) 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>가. 골다공증에 다음과 같이 투여 시 인정함.</u> <u>- 다 음 -</u> 1) 투여대상 <u>가)</u> 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle, <u>Trochanter</u> 제외)]: 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 ($T\text{-score} \leq -2.5$). <u>나)</u> 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT): 80mg/cm³ 이하인 경우 <u>다)</u> 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, 글루코코르티코이드 유발 골다공증에 급여를 확대함.

	확인된 경우 * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 <u>나.</u> 투여기간 <u>1)</u> 투여대상 <u>1)</u>, <u>2)</u>에 해당하는 경우에는 1년(2회), <u>3)</u>에 해당하는 경우에는 3년(6회)로 하며, 추적검사에서 T-score가 -2.5 이하(QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. <u>2)</u> 다만, <u>가.</u> 투여대상 <u>1)</u>에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 <u>가.</u> 투여대상 <u>1)</u>에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하($-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$)에 해당될 경우 1년(2회) 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하($-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$)에 해당될 경우 1년(2회)의 추가투여를 급여 인정함.* ※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속투여는 2년(4회)(1년(2회) + 1년(2회))까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제,	확인된 경우 * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 <u>2)</u> 투여기간 <u>가)</u> 투여대상 <u>가)</u>, <u>나)</u>에 해당하는 경우에는 1년(2회), <u>다)</u>에 해당하는 경우에는 3년(6회)로 하며, 추적검사에서 T-score가 -2.5 이하(QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함. <u>나)</u> 다만, <u>1)</u> 투여대상 <u>가)</u>에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 <u>1)</u> 투여대상 <u>가)</u>에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하($-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$)에 해당될 경우 1년(2회) 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하($-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$)에 해당될 경우 1년(2회)의 추가투여를 급여 인정함.* ※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속투여는 2년(4회)(1년(2회) + 1년(2회))까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제,	
--	--	--	--

	Bisphosphonate 개별 성분, 동 약제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능함.) <u>다.</u> 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음. <u><추 가></u>	Bisphosphonate 개별 성분, 동 약제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능함.) <u>3)</u> 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음. <u>나. 글루코코르티코이드 (Glucocorticoid) 투여 환자의 경우 다음과 같은 기준으로 요양급여를 인정함.</u> <u>- 다 음 -</u> <u>1) 투여대상</u> <u>6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 prednisolone을 총 450mg 이상(또는 그에 상응하는 글루코코르티코이드 약제 용량)을 투여받은 환자로서</u> <u>가) 폐경 후 여성 및 만 50세 이상 남성 :</u> <u>$T\text{-score}^{*} < -1.5$</u> <u>나) 폐경 전 여성 및 만 50세 미만 남성 :</u> <u>$Z\text{-score}^{*} < -3.0$</u> <u>※ 중심골[Central bone; 요추, 대퇴 (Ward's triangle, Trochanter 제외)]을 이중 에너지 방사선 흡수계측 (Dual-Energy X-ray Absorptiometry:</u>	
--	--	---	--

		<u>DXA)을 이용하여 측정해야 한다.</u> <u>2) 투여기간</u> <u>1년(2회)로 하며, 추적검사에서 1)의 기준이 유지되고 약제투여가 계속 필요한 경우는 급여토록 함.</u> <u>3) <u>Bisphosphonate제제(Alendronate, Risedronate 경구제, Zoledronic acid 주사제)로 전환 투여는 최대 12개월까지 인정하되, 동 약제 투여 종료 후 마지막 투여일로부터 7개월 이내에 투여를 시작하여야 함.</u></u>	
[399] Zoledronic acid 5mg/100ml 주사제(품명: 대웅졸레드론산 주사액 5밀리그램/100밀리리터 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. X선 소견에서 확인된 골파제트병(Paget's disease) 나. 골다공증에 투여 시 골다공증치료제 일반원칙을 따르며, 다음과 같은 대상에게 투여 시 인정함 - 다 음 - 1) 투여대상 가) 중심골(Central bone; 요추, 대퇴(Ward's	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. X선 소견에서 확인된 골파제트병(Paget's disease) 나. 골다공증에 투여 시 골다공증치료제 일반원칙을 따르며, 다음과 같은 대상에게 투여 시 인정함 - 다 음 - 1) 투여대상 가) 중심골(Central bone; 요추, 대퇴(Ward's	

	triangle <추 가> 제외]] : 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 나) 정량적 전산화 단층 골밀도검사(QCT) : 80mg/cm³ 이하인 경우 다) 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이 확인된 경우 * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 2) 투여횟수 및 기간: 1회/년 가) 투여대상 가), 나)에 해당하는 경우 1회, 다)에 해당하는 경우 3회 인정하며, 추적검사상에서 T-score가 -2.5 이하(QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우 총 6회까지 인정함 나) 다만, 1) 투여대상 가)에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 1) 투여대상 가)에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하(-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하(-2.5<T-score≤	triangle, Trochanter 제외]] : 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우 나) 정량적 전산화 단층 골밀도검사(QCT) : 80mg/cm³ 이하인 경우 다) 방사선 촬영 등에서 골다공증성 골절*이 확인된 경우 * 골다공증성 골절 인정가능 부위: 대퇴골, 척추, 요골, 상완골, 골반골, 천골, 발목골절 2) 투여횟수 및 기간: 1회/년 가) 투여대상 가), 나)에 해당하는 경우 1회, 다)에 해당하는 경우 3회 인정하며, 추적검사상에서 T-score가 -2.5 이하(QCT 80mg/cm³ 이하)로 약제투여가 계속 필요한 경우 총 6회까지 인정함 나) 다만, 1) 투여대상 가)에 해당하여 투여 후, 추적검사에서 1) 투여대상 가)에 따른 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 초과 -2.0 이하(-2.5<T-score≤-2.0)에 해당될 경우 1년 추가투여를 급여 인정하며, 이후에도 T-score가 -2.5 초과 -2.0이하(-2.5<T-score≤	
--	--	---	--

	-2.0)에 해당될 경우 1년의 추가투여를 급여 인정함.* ※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속 투여는 2년(1년 + 1년)까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제, Denosumab 주사제, Bisphosphonate 타 성분 및 동 약제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능하며, 동 약제 총 투여횟수는 2) 투여횟수 및 기간 가), 나)를 통틀어 총 6회까지 인정함. 3) 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음. 다. 글루코코르티코이드(Glucocorticoid) 투여환자의 경우 아래와 같은 기준으로 요양급여를 인정함. - 아 래 - 1) 투여대상 6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 prednisolone을 총 450mg 이상(또는 그에 상응하는 글루코코르티코이드 약제 용량)을 투여받은 환자로서 가) 폐경 후 여성 및 만 50세 이상 남성 : T-score	-2.0)에 해당될 경우 1년의 추가투여를 급여 인정함.* ※ $-2.5 < T\text{-score} \leq -2.0$ 범위에서 연속 투여는 2년(1년 + 1년)까지 인정하며, 2년 내에서 Raloxifene, Bazedoxifene 제제, Denosumab 주사제, Bisphosphonate 타 성분 및 동 약제 사이에 용법·용량을 고려하여 교체투여 가능하며, 동 약제 총 투여횟수는 2) 투여횟수 및 기간 가), 나)를 통틀어 총 6회까지 인정함. 3) 단순 X-ray는 골다공증성 골절 확인 진단법으로만 사용할 수 있음. 다. 글루코코르티코이드(Glucocorticoid) 투여환자의 경우 아래와 같은 기준으로 요양급여를 인정함. - 아 래 - 1) 투여대상 6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 prednisolone을 총 450mg 이상(또는 그에 상응하는 글루코코르티코이드 약제 용량)을 투여받은 환자로서 가) 폐경 후 여성 및 만 50세 이상 남성 : T-score	
--	--	--	--

	※ < -1.5 나) 폐경 전 여성 및 만 50세 미만 남성 : Z-score ※ < -3.0 ※ 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle <추 가> 제외)]을 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 측정해야 한다. 2) 투여 횟수 - 1회 인정하며, 추적검사에서 1) 의 기준이 유지되고 약제 투여가 계속 필요한 경우에 총 6회까지 인정함. <u><추 가></u>	※ < -1.5 나) 폐경 전 여성 및 만 50세 미만 남성 : Z-score ※ < -3.0 ※ 중심골[Central bone; 요추, 대퇴(Ward's triangle, Trochanter 제외)]을 이중 에너지 방사선 흡수계측(Dual-Energy X-ray Absorptiometry: DXA)을 이용하여 측정해야 한다. 2) 투여 횟수 - 1회 인정하며, 추적검사에서 1) 의 기준이 유지되고 약제 투여가 계속 필요한 경우에 총 6회까지 인정함. <u>라. 글루코코르티코이드 관련하여 Denosumab 투여 후 전환투여는 1회 인정하되, Denosumab 투여 종료 후 마지막 투여일로 부터 7개월 이내에 투여하여야 함.</u>	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e. 2025. · Current Diagnosis & Treatment: Rheumatology, 4e. 2021. · Korean Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-induced Osteoporosis. 2018. · 2022 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. · NOGG. 2024.			

- The 2023 Guidelines for the management and treatment of glucocorticoid induced osteoporosis.
- Saag et al. Denosumab versus risedronate in glucocorticoid-induced osteoporosis: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, double-dummy, non-inferiority study. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6: 445–54.
- Saag et al. Denosumab Versus Risedronate in Glucocorticoid-Induced Osteoporosis: Final Results of a Twenty-Four-Month Randomized, Double-Blind, Double-Dummy Trial. Arthritis & Rheumatology. Vol. 71, No. 7, July 2019, pp 1174–1184.
- Yuan et al., Clinical efficacy of denosumab, teriparatide, and oral bisphosphonates in the prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2023) 18:447.
- Dong et al., Denosumab, teriparatide and bisphosphonates for glucocorticoid-induced osteoporosis: a Bayesian network meta-analysis. Front. Pharmacol, 2024. 15:1336075.

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[439] Anakinra (품명 : 키너렛주)	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확진된 환자의 류마티스(자가염 증질환) 증상의 경감 ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확진된 환자의 류마티스(자가염 증질환) 증상의 경감 ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위	○ 식품의약품안전처장이 인정한 긴급도입 의약품 인정 범위 변경과 관련하여 급여 인정범위를 명확히 함

	○ 다음에 해당하는 류마티스(자가염증질환) 증상의 경감 - 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확진된 환자 ○ CAR-T 세포 치료 후 발생가능한 사이토카인방출 증후군(CRS), 신경독성증후군(ICANS), 혈구탐식성 림프조직구증(IEC-HLH) 치료 ○ 슈니츨러증후군(Schnitzler syndrome) 치료	○ 다음에 해당하는 류마티스(자가염증질환) 증상의 경감 - 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확진된 환자 ○ CAR-T 세포 치료 후 발생가능한 사이토카인방출 증후군(CRS), 신경독성증후군(ICANS), 혈구탐식성 림프조직구증(IEC-HLH) 치료 ○ 슈니츨러증후군(Schnitzler syndrome) 치료 ○ 대식세포 활성화 증후군(MAS) 치료	
※ 관련근거 · 식품의약품안전처 의약품관리지원팀-491호(2026.1.28.) “긴급도입 의약품 인정 범위 확대 안내”			